MPASI mulai 6 bulan, tekstur naik bertahap, protein hewani tiap makan utama.

Cek red flags, tab usia, feeding rules, dan tumbuh kembang.

Ringkas 1 kalimat: mulai MPASI di usia 6 bulan, naikkan tekstur sesuai usia, utamakan protein hewani tiap makan utama, pakai feeding rules konsisten, dan cek cepat bila ada tanda bahaya.

2) Red Flags: Kapan harus ke dokter/IGD

Cek tanda bahaya dulu sebelum fokus ke tips makan.

Ke IGD segera bila anak sangat lemas, tidak mau minum sama sekali, muntah hijau/berdarah, sesak, bibir kebiruan, kejang, atau dehidrasi berat (pipis sangat sedikit, mata cekung, mulut sangat kering).

Red flag makan

- Asupan hampir nol lebih dari 24 jam.
- Sering tersedak berat, batuk hebat saat makan/minum.
- Berat badan turun atau tidak naik 1 bulan.

Red flag infeksi

- Demam tinggi menetap lebih dari 3 hari.
- Diare berulang disertai muntah dan minum sangat kurang.
- Anak sangat mengantuk dan sulit dibangunkan.

Red flag perkembangan

- Kemampuan yang sudah ada lalu hilang.
- Menolak semua tekstur baru berbulan-bulan.
- Masalah makan sampai mengganggu aktivitas harian.

Nuansa lokal: kalau ada ucapan “engke oge lapar sorangan”, tetap boleh dipakai untuk kondisi ringan. Tapi kalau ada red flags, jangan tunggu.

3) 7 Pesan Emas Pemberian Makan Anak

Tujuh poin ini jadi pegangan harian agar nasihat tidak campur aduk.

1. Mulai MPASI usia 6 bulan

Tidak terlalu cepat, tidak terlalu telat. ASI tetap lanjut.

2. Naikkan tekstur bertahap

Dari lumat ke cincang ke makanan keluarga, jangan lama di makanan terlalu cair.

3. Protein hewani tiap makan utama

Telur, ikan, ayam, daging, hati sesuai usia dan toleransi.

4. Jadwal makan konsisten

Makan utama + selingan teratur, bukan ngemil terus sepanjang hari.

5. Responsive feeding

Arahkan dengan sabar, tanpa paksa, tanpa ancaman, tanpa marah.

6. Jaga kebersihan makanan

Cuci tangan, alat bersih, air aman, bahan matang sempurna.

7. Pantau pertumbuhan rutin

Lihat tren di Buku KIA/KMS, bukan angka tunggal.

4) Tab Usia: Frekuensi, Tekstur, Porsi, Isi Piring

Pilih tab sesuai umur anak, lalu cek frekuensi, tekstur, porsi, dan kapan perlu evaluasi.

6-8 bulan | 9-11 bulan | 12-23 bulan | 2-5 tahun

Frekuensi harian

- MPASI 2-3 kali per hari.
- Selingan 1-2 kali per hari bila bayi siap.
- ASI tetap lanjut sesuai kebutuhan bayi.

Tekstur & porsi

- Tekstur lumat/kental, bukan encer.
- Mulai 2-3 sendok, naik bertahap sampai sekitar 1/2 mangkok 250 ml tiap makan.
- Ikuti sinyal lapar dan kenyang bayi.

Proporsi isi makan

- Dalam satu menu ada karbo, protein, sayur/buah halus.
- Protein hewani mulai rutin tiap makan utama.
- Contoh lokal: tim nasi + ayam/ikan + labu/wortel.

Kapan evaluasi medis

- Sering muntah atau tersedak.
- Menolak makan terus lebih dari 2 minggu.
- Berat tidak naik sesuai pemantauan.

Visual ini hanya untuk orientasi porsi. Angka dan keputusan tetap pakai panduan tertulis di bawah.

1/2 piring sayur + buah

Utamakan sayur lebih banyak, lalu tambah buah potong sesuai usia dan kebiasaan makan anak.

1/2 piring makanan pokok + lauk

Makanan pokok boleh lebih banyak daripada lauk, selama protein hewani tetap hadir di makan utama.

5) Feeding Rules: Jadwal, Durasi, Lingkungan, Prosedur

Jadwal dan suasana makan yang konsisten sering lebih berpengaruh daripada menu mahal.

Jadwal

- Makan utama dan selingan terjadwal.
- Jeda antar makan cukup supaya anak lapar.
- Susu/minuman lain jangan menabrak jam makan.

Durasi

- Batasi 20-30 menit per sesi makan.
- Jika anak menolak terus, akhiri tenang.
- Coba lagi di jadwal makan berikutnya.

Lingkungan

- Duduk di kursi makan/meja makan.
- Tanpa TV, HP, atau distraksi layar.
- Suasana makan hangat dan tidak menegangkan.

Prosedur responsif

- Porsi kecil dulu, tambah bila habis.
- Tawarkan ulang saat anak siap, tanpa memaksa.
- Puji usaha anak, bukan sekadar jumlah suapan.

- [ ] Jadwal makan hari ini konsisten (utama + selingan).
- [ ] Durasi makan tidak lebih dari 30 menit.
- [ ] Saat makan tanpa HP/TV.
- [ ] Protein hewani ada di makan utama.

6) Cara Mengenalkan Makanan Baru

Kenalkan bahan baru pelan-pelan supaya aman dan tidak bikin orang tua panik.

Aturan praktis: kenalkan 1 bahan baru setiap 3-5 hari, pantau respon tubuh, lalu lanjut bahan berikutnya.

Langkah 3-5 hari +

Alergen dan tersedak +

Kapan stop dan periksa +

7) GTM: Gerakan Tutup Mulut dan Cara Mengatasinya

Mulai dari penyebab yang paling sering: jadwal berantakan, tekstur tidak pas, atau pengalaman makan yang menegangkan.

Apa itu GTM

- Anak menutup rapat mulut, memalingkan kepala, melepehkan makanan, atau marah saat sesi makan.
- Sering muncul saat transisi tekstur atau saat anak kurang fit.

Penyebab umum

- Tekstur tidak sesuai tahap usia.
- Ngemil/minum manis terlalu sering jadi tidak lapar.
- Trauma makan karena dipaksa atau dimarahi.

Langkah 7-14 hari

- Reset jadwal makan, batasi sesi 30 menit.
- Hilangkan distraksi layar saat makan.
- Porsi kecil dulu, fokus konsistensi, bukan kejar banyak.

Kapan wajib periksa

- GTM tetap > 2 minggu walau feeding rules sudah konsisten.
- Berat turun/mendatar, anak tampak lemas.
- Curiga nyeri menelan atau gangguan oral-motor.

Ke dokter/IGD segera jika GTM disertai dehidrasi, muntah terus, sulit minum, atau penurunan kesadaran.

8) Pemantauan Pertumbuhan

Lihat tren berat dan tinggi, bukan satu angka tunggal.

Cara baca tren

- Fokus ke arah kurva, bukan angka sekali timbang.
- Kurva yang stabil-naik lebih baik daripada naik-turun tajam.
- Bila garis berat mendatar atau turun berulang, perlu evaluasi penyebab makan/sakit.

Jadwal ukur menurut usia

- 0-24 bulan: idealnya ditimbang dan diukur tiap bulan.
- 2-5 tahun: minimal tiap 3 bulan, lebih sering bila ada masalah makan/penyakit.
- Gunakan alat ukur yang sama bila memungkinkan agar tren lebih konsisten.

Indikator keberhasilan mingguan-bulanan

- Anak lebih aktif, mood lebih stabil, tidur lebih baik.
- Pola makan lebih teratur dan tidak terus GTM.
- Grafik berat/tinggi bergerak sesuai jalur pertumbuhan anak.

Langkah pencatatan di rumah

- Tulis menu harian dan jumlah makan utama/selingan.
- Catat periode sakit (demam, batuk, diare, muntah).
- Simpan hasil timbang-ukur terakhir untuk dibawa saat kontrol.

Red flags pertumbuhan

- Berat tidak naik 1 bulan atau turun.
- Kurva turun lintas garis pertumbuhan.
- Pakaian makin longgar, anak cepat lelah, aktivitas menurun.

Kapan kontrol cepat

- Asupan turun jelas lebih dari 3-5 hari.
- GTM lebih dari 2 minggu meski aturan makan sudah konsisten.
- Ada red flags lain: dehidrasi, muntah berulang, diare berat, demam lama.

Tips praktis: setiap datang ke posyandu/puskesmas, langsung cocokkan angka terbaru ke grafik. Jangan menunggu sampai beberapa bulan baru dicek.

9) Pemantauan Perkembangan

Pantau bahasa, motorik, sosial, dan kemandirian sambil tetap melihat pola makan.

Domain yang dipantau

- Motorik kasar: duduk, berdiri, jalan, lari sesuai tahap usia.
- Motorik halus: memegang, menjumput, menyuap, coret-coret.
- Bahasa: celoteh, kata bermakna, respon instruksi sederhana.
- Sosial-kemandirian: kontak mata, bermain bergantian, mau mencoba makan sendiri.

Stimulasi saat makan

- Ajak anak pegang sendok sesuai usia.
- Sebut nama makanan, warna, rasa, dan tekstur.
- Latih duduk fokus sampai sesi makan selesai.
- Beri pilihan terbatas: misalnya \"mau wortel atau bayam dulu?\"

Stimulasi saat bermain

- Motorik kasar: main bola, naik-turun aman, jalan di garis.
- Motorik halus: susun balok, pindah benda kecil aman, mencoret.
- Bahasa: baca buku gambar, tiru suara, nyanyi sederhana.
- Sosial: role play sederhana, belajar giliran, puji perilaku positif.

Batas observasi sebelum evaluasi

- Boleh observasi 2-4 minggu untuk keterlambatan ringan sambil stimulasi konsisten.
- Kalau tidak ada progres jelas, segera konsultasi.
- Jangan tunda bila ada regresi kemampuan atau red flags neurologis.

Alarm klinis spesifik

- Anak kehilangan kemampuan yang sebelumnya sudah dikuasai.
- Sangat minim kontak mata/interaksi dua arah.
- Sulit menelan, sering tersedak, atau menolak hampir semua tekstur.

Kapan evaluasi medis

- Milestone terlambat jelas dari rentang usia.
- Perkembangan bicara sangat lambat disertai gangguan interaksi.
- Orang tua merasa ada \"yang tidak seperti biasanya\" meski sulit dijelaskan.

Catatan: perkembangan tiap anak memang unik, tapi red flags tetap harus dianggap serius agar intervensi tidak terlambat.

10) Resep Lokal Sehari-hari + Makanan yang Dibatasi

Menu lokal bisa tetap padat gizi bila tekstur dan lauknya disesuaikan usia.

Menu 6-8 bulan (tekstur lumat/kental)

- Pagi: bubur tim beras + ayam + wortel halus.
- Siang: bubur kentang + ikan + labu halus.
- Malam: bubur beras + telur + bayam halus.
- Selingan: buah lumat (pisang/pepaya) atau bubur kacang hijau kental halus.

Menu 9-11 bulan (lumat kasar/cincang lembut)

- Pagi: nasi tim lembek + telur orak-arik + tomat halus.
- Siang: nasi lembek + pepes ikan non-pedas + sayur cincang halus.
- Malam: bubur oat kental + ayam cincang + brokoli lunak.
- Selingan: potongan buah lunak kecil atau tahu kukus lembut.

Menu 12-23 bulan (makanan keluarga potong aman)

- Pagi: nasi + telur dadar iris + tumis bayam lembut.
- Siang: nasi + semur ayam + sayur bening + buah potong.
- Malam: nasi + ikan kuah kuning non-pedas + tumis buncis lembut.
- Selingan: jagung lembut pipil halus, ubi kukus, atau yoghurt plain sesuai toleransi.

Menu 2-5 tahun (makanan keluarga terjadwal)

- Pagi: nasi/lontong + telur + sayur.
- Siang: nasi + lauk hewani + sayur + buah.
- Malam: nasi + tahu/tempe + ikan/ayam + sayur.
- Selingan: buah, puding rumahan rendah gula, atau roti isi telur/keju secukupnya.

Makanan dibatasi + alasan

- Minuman manis kemasan/teh manis/sirup: bikin cepat kenyang palsu, risiko gigi dan berat badan tidak sehat.
- Gorengan terlalu sering (bala-bala/gehu harian): lemak berlebih, mudah menggantikan menu utama.
- Makanan ultra-proses tinggi gula/garam: bisa mengganggu pola lapar alami dan kebiasaan rasa.
- Makanan bulat keras/utuh (anggur utuh, kacang utuh): risiko tersedak.

Alternatif aman

- Ganti minuman manis dengan air putih atau susu sesuai anjuran usia.
- Camilan garing tinggi garam diganti buah potong, umbi kukus, atau olahan rumah minim gula.
- Buat versi anak dari menu keluarga: bumbu lembut, non-pedas, potongan aman.
- Utamakan lauk protein dulu, camilan diberikan sesuai jadwal selingan.

Kapan evaluasi medis

- Asupan tetap minim meski menu dan jadwal sudah dibenahi 2-4 minggu.
- Anak muntah berulang atau sering tersedak pada banyak jenis menu.
- Berat stagnan/turun disertai anak terlihat lemas.

> Tips dapur: buat batch kecil 1-2 kali masak per hari agar makanan tetap segar, tekstur lebih sesuai, dan risiko kontaminasi lebih rendah.

11) Anemia

Pucat, mudah lelah, atau nafsu makan turun perlu dikaitkan dengan risiko kurang zat besi.

Faktor risiko

- Asupan zat besi kurang setelah usia 6 bulan.
- Lahir prematur/berat lahir rendah atau riwayat anemia ibu saat hamil.
- Pola makan sangat terbatas, dominan karbo dan minim lauk hewani.

Tanda klinis sederhana

- Pucat pada bibir/gusi/kelopak mata.
- Anak tampak cepat lelah, lesu, kurang aktif.
- Nafsu makan menurun, mudah rewel, kadang sulit fokus.

Pencegahan harian

- Sumber zat besi: daging, hati, ayam, ikan, telur, kacang-kacangan.
- Padukan dengan vitamin C (jeruk, tomat, jambu, pepaya) agar serapan besi lebih baik.
- Batasi minuman manis saat jam makan karena menggeser asupan bergizi.

Contoh pairing menu

- Nasi + ayam/ikan + tumis sayur + potongan pepaya.
- Bubur kacang hijau kental + buah tinggi vitamin C.
- Telur + sayur + tomat/jeruk setelah makan utama.

Kapan cek Hb / kontrol

- Anak terlihat pucat lebih dari 1-2 minggu.
- Terdapat gejala lemas berkepanjangan, nafsu makan turun, berat stagnan.
- Ada faktor risiko tinggi dan respons makan tidak membaik.

Catatan: keputusan pemeriksaan Hb dan terapi besi tetap perlu evaluasi dokter agar dosis dan lama terapi tepat.

12) Kebersihan Makanan

Makanan bergizi tetap harus lewat alur yang bersih dan aman.

1) Sebelum menyiapkan makanan

- Cuci tangan pakai sabun minimal 20 detik sebelum masak dan sebelum menyuapi.
- Bersihkan meja, talenan, sendok, blender, dan wadah makan.
- Bedakan alat untuk bahan mentah dan makanan matang bila memungkinkan.

2) Pemilihan bahan

- Pilih bahan segar, tidak bau, tidak berlendir, tidak berubah warna.
- Gunakan air bersih untuk mencuci bahan dan memasak.
- Hindari produk tidak dipasteurisasi untuk anak kecil.

3) Pemasakan matang

- Masak lauk hewani sampai matang merata.
- Panaskan ulang makanan sisa sampai benar-benar panas sebelum disajikan lagi.
- Jangan mencampur makanan matang dengan bahan mentah.

4) Penyimpanan aman

- Makanan yang tidak habis segera ditutup dan simpan di suhu aman.
- Jangan biarkan makanan matang terlalu lama di suhu ruang.
- Berikan label waktu simpan agar tidak lupa kapan harus dibuang.

5) Alat makan dan minum anak

- Cuci botol, cup, sedotan, sendok dengan air bersih dan sabun lalu keringkan.
- Periksa bagian sempit (sedotan/tutup botol) karena mudah jadi tempat kuman.
- Ganti alat yang retak, kusam berat, atau sulit dibersihkan.

6) Keamanan saat makan

- Anak duduk saat makan, tidak sambil lari atau bermain.
- Potong makanan sesuai ukuran aman untuk usia anak.
- Hindari makanan risiko tersedak: bulat keras, kecil-lengket, atau utuh.

5 pesan inti keamanan pangan: jaga kebersihan, pisahkan mentah-matang, masak matang sempurna, simpan pada suhu aman, dan gunakan air/bahan yang aman.

Kapan ke dokter: muntah hebat, diare berulang dengan minum sangat kurang, demam tinggi, darah pada tinja/muntah, atau tanda dehidrasi.

13) Mitos vs Fakta

Luruskan dulu nasihat yang sering bikin orang tua salah fokus.

Mitos: GTM cukup ditutup susu

Fakta: susu tidak menggantikan keragaman makanan padat bergizi.

Mitos: belum banyak gigi belum boleh tekstur

Fakta: tekstur tetap perlu naik bertahap sesuai usia dan kemampuan anak.

Mitos: makanan bergizi harus mahal

Fakta: telur, ikan lokal, tahu-tempe, sayur, buah lokal sudah sangat membantu bila rutin.

14) FAQ Singkat

Pegangan singkat untuk pertanyaan yang paling sering muncul di rumah.

Kalau anak lagi sakit, jadwal makan gimana? +

Anak cuma mau satu menu favorit, boleh terus? +

Perlu vitamin penambah nafsu makan? +

Catatan Kondisi Khusus

Beberapa anak perlu target yang lebih personal sejak awal.

Untuk anak prematur, penyakit kronis (misalnya jantung, ginjal, saraf, gangguan cerna), atau alergi berat, rencana makan harus disusun individual bersama tenaga kesehatan.

Yang dibawa saat konsultasi

- Catatan makan 3 hari terakhir.
- Catatan minum/susu harian.
- Data berat dan tinggi terbaru.

Target konsultasi

- Porsi sesuai kondisi klinis anak.
- Tekstur aman dan realistis di rumah.
- Jadwal kontrol lanjutan yang jelas.

15) Rujukan Utama

Rujukan resmi ini dipakai untuk menjaga isi tetap selaras dengan panduan pasien.

1. Kemenkes RI (Ayo Sehat): Buku PMBA untuk kader.
2. Kemenkes RI: Kumpulan link MPASI.
3. WHO: Complementary feeding.
4. WHO Guideline 2023: Complementary feeding of infants and young children 6-23 months.
5. WHO: Five keys to safer food.
6. UNICEF: Feeding your baby 6-12 months.
7. UNICEF: Feeding your child 1-2 years.
8. CDC (update 20 Maret 2025): Tastes and textures dan introducing solid foods.
9. IDAI: Gerakan Tutup Mulut (GTM) pada batita.
10. IDAI: Sulit makan pada bayi dan anak.

Print / Save PDF

Simpan halaman ini untuk dipakai offline atau dibawa saat kontrol. Untuk hubungi klinik, pakai tombol WhatsApp dan Instagram di hero atau link footer.

Status koneksi: online. Tautan rujukan dan kontak bisa dibuka.

Zihan Medical Center

#ZMCGakNyuekinKamu - layanan 24 jam.

Jl. Kudang, Wanajaya, Wanaraja, Wanajaya, Garut, Kabupaten Garut, Jawa Barat 44183

Telepon: +62 822-1718-0432

Jam: Senin - Minggu: 24 Jam

Kontak & Lokasi

WhatsApp

Maps

Instagram

Tip offline: simpan file ini bersama `zmc-logo.jpeg` di folder yang sama.

© 2026 Zihan Medical Center - Wanaraja Garut

Konten edukasi pasien. Bukan pengganti pemeriksaan langsung.